TEMA 1 · Fundamentos de Enfermería, Modelos teóricos y Constitución

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Historia y profesión · Bloque B: Modelos y teorías · Bloque C: Constitución y Estatuto de Murcia

A1. Historia de la enfermería: las 4 etapas

Etapa	Época	Claves
Doméstica	Prehistoria y civilizaciones antiguas	Cuida la mujer del grupo. Visión mágico-religiosa (chamán). **Paleoenfermería** = estudio de esos cuidados
Vocacional	Cristianismo hasta fin de la Edad Moderna	Cuidar = caridad cristiana. La Iglesia asume la atención: monasterios, órdenes religiosas
Técnica	Siglo XIX	Profesionalización laica y primera formación reglada (Fliedner, Nightingale)
Profesional	Siglos XX-XXI	Profesión autónoma: universidad, colegios, especialidades, investigación

Etapa doméstica: civilizaciones antiguas

- **Egipto**: **papiro de Ebers**. Mucha higiene y salud pública; médicos especializados por patologías; partos con comadronas.
- **Mesopotamia**: **Código de Hammurabi (ca. 1750 a.C.)**, la **primera reglamentación escrita del ejercicio sanitario**. **No menciona la enfermería**.
- **Hebreos**: la enfermedad es un castigo divino, pero reconocen el **contagio**, el **aislamiento** y la notificación. La **Ley Mosaica** regula la higiene. **Débora** es la **primera enfermera reconocida**.
- **India**: **Vedas (ca. 1600 a.C.)**. El texto **Kaviratna** dice que los cuidadores deben ser hombres jóvenes (o mujeres ancianas).
- **China**: salud = armonía con el universo, equilibrio **Yin-Yang**.
- **Grecia**: se pasa de una visión teúrgica a una naturalista. **Hipócrates (s. V a.C.)**, "padre de la medicina", con la **Teoría Humoral** (4 humores). Templos de **Asclepio**.
- **Roma**: medicina militar; los **nosocomi** son los antecesores de camilleros y enfermeros de campaña. **Galeno (s. II d.C.)**. Con el **Edicto de Tesalónica** surgen los **xenodoquios** (hospicios), precursores de los hospitales.

Etapa vocacional (Edad Media y Edad Moderna)

- **Alta Edad Media**: **San Benito de Nursia (s. VI)** y la Orden Benedictina, con obligación de atender a enfermos. **Escuela de Salerno (s. IX)**, que admitía mujeres. **Hôtel-Dieu de París (s. VII)**. Diaconisas, Agustinas y **beguinas** (Flandes).
- **Baja Edad Media** (Cruzadas): órdenes militares (**Hospitalarios de San Juan de Jerusalén / Malta**, San Lázaro), mendicantes (Franciscanos, Dominicos) y cofradías seglares.
- **Reforma Protestante**: cierra instituciones en el norte de Europa y abre la **"época oscura" de la enfermería**. Cuidan reclusas y mujeres marginales.
- **España, ss. XVI-XVII** (Trento): **"época áurea"**. **Orden de San Juan de Dios (Pío V, 1572)**; **Hijas de la Caridad (París, 1633)**. Aparecen los primeros manuales escritos por enfermeros.

Etapa técnica (s. XIX)

- **Elizabeth Fry** (Inglaterra, 1840): institución de formación para cuidadoras visitadoras.
- **Theodor Fliedner** (Alemania, **1836**): **Instituto de Diaconisas de Kaiserswerth**, con formación de 3 años. Allí se forma Nightingale.
- **Florence Nightingale (1820-1910)**: madre de la enfermería moderna.
  - **Guerra de Crimea (1854-56)**, hospital de **Scutari** (Turquía): reduce la mortalidad con higiene, nutrición y organización.
  - ***Notes on Nursing*** **(1859)**.
  - **1860**: **primera escuela laica de enfermería**, en el **Hospital St. Thomas de Londres**.
  - **Primera enfermera investigadora**: usa la estadística y los gráficos de áreas.
- **España**: antes había **practicantes** (hombres, curas menores), **matronas** (partos) y religiosas.

- **Ley Moyano (Instrucción Pública, 1857)**: regula los títulos de practicante y matrona, pero **NO el de enfermera**.
- **1915, Real Orden**: crea el **título de Enfermera** en España, a instancias de las **Siervas de María**.
- **Concepción Arenal** (desde 1860): propone **unificar enfermera, practicante y matrona** en un solo título y escuela.

Etapa profesional (ss. XX-XXI): cronología España e internacional

Año	Hito
1899	Se funda el **Consejo Internacional de Enfermeras (CIE)**, con código deontológico internacional
1912	Colegios Oficiales de **practicantes** (en **1928** se incluyen las enfermeras)
1944	Colegio único de "**Auxiliares Sanitarios**"
1953	Se unifican enfermera, practicante y matrona en el título de **ATS**
1970	**Ley General de Educación**: la formación de ATS pasa a la universidad
1977	**RD 2128/1977**: Escuelas Universitarias de Enfermería, **diplomatura de 3 años** (más de 4.500 h). Se crea el **Consejo General de Colegios de Enfermería**
1980	Curso de nivelación de ATS a **DUE**
1999	**Proceso de Bolonia** (Espacio Europeo de Educación Superior)
2005	**RD 450/2005**: **7 especialidades** vía **EIR**
2007	**Grado en Enfermería (4 años)**, con acceso a máster y doctorado
2020	Bicentenario de Nightingale: la OMS declara el **Año Internacional de la Enfermera y la Matrona**; campaña **Nursing Now** (OMS + CIE)

Las 7 especialidades (RD 450/2005): Obstétrico-Ginecológica (Matrona), Salud Mental, Geriátrica, del Trabajo, Familiar y Comunitaria, Pediátrica y Cuidados Médico-Quirúrgicos.

TRAMPAS DE EXAMEN

! El Código de Hammurabi regula el ejercicio sanitario, pero NO menciona la enfermería.
! La primera escuela laica fue St. Thomas (1860, Londres). Kaiserswerth (1836) era protestante (diaconisas).
! La Ley Moyano (1857) NO crea el título de enfermera; eso llega en 1915.
! "Época oscura" = países protestantes. "Época áurea" = España (ss. XVI-XVII).
! El CIE es de 1899; el Consejo General de Colegios de Enfermería de España, de 1977.

A2. La enfermería como disciplina y profesión

DISCIPLINA (la ciencia)	PROFESIÓN (la práctica)
Cuerpo de **conocimientos científicos propios**, generado por investigación y teorías	**Ejercicio práctico** de esos conocimientos para prestar un **servicio específico a la sociedad**
Se define por su **marco conceptual, método científico y lenguaje propio**	Se distingue por su **autonomía, código ético y compromiso social** (y, normalmente, retribución)

- "La teoría sin práctica está vacía y la práctica sin teoría es ciega."
- **Kérouac** define la disciplina así: "la enfermera se interesa por el **cuidado** de la **persona** que, en interacción con su **entorno**, vive experiencias de **salud**" (contiene los 4 conceptos del metaparadigma).
- **Philip Elliott**: las profesiones con un cuerpo de conocimientos más teórico convencen mejor a la sociedad de que sus servicios son necesarios.
- **Etapas del desarrollo del conocimiento**: **curricular** (qué hacer), luego **investigación** (por qué funciona) y finalmente **teórica** (qué es la enfermería).

B1. Jerarquía del conocimiento y metaparadigma

De más abstracto a más concreto: Filosofía, Ciencia, Disciplina, Paradigma, **Metaparadigma** y, por último, Modelos y Teorías.

- **Paradigma**: corriente de pensamiento o manera de ver el mundo.
- **Metaparadigma**: el marco **más global y abstracto** de la disciplina.

- **Modelo vs teoría**: la diferencia principal es el **nivel de abstracción**. El modelo es más abstracto y global; la teoría es más concreta (describe, explica, predice o prescribe).

Metaparadigma enfermero: Jacqueline Fawcett

Son 4 conceptos que toda teoría debe definir: **PERSONA, ENTORNO, SALUD y CUIDADO (ENFERMERÍA)**.

- **Persona**: quien recibe los cuidados (individuo, familia, grupo o comunidad).
- **Entorno**: condiciones externas físicas, sociales, culturales y psicológicas.
- **Salud**: un continuo que va del bienestar a la enfermedad y la muerte.
- **Cuidado**: las acciones propias de la enfermera.
- **Hernández Conesa**: critica que "enfermería" no es de la misma categoría lógica que los otros tres (son las acciones sobre ellos). Plantea relaciones persona-salud, persona-entorno, salud-cuidados y persona-entorno-salud.

Elementos comunes de los modelos

- **Supuestos**: premisas aceptadas sin demostración.
- **Sistema de valores**: lo que la teórica considera importante o deseable.
- **Principios**: meta de la enfermería, rol del profesional, origen del problema, enfoque de la intervención y consecuencias esperadas.

Criterios para evaluar teorías (Fawcett; también Marriner-Alligood)

Claridad, Simplicidad, Generalidad, Precisión empírica y Consecuencias deducibles. Marriner-Tomey y Alligood analizaron **51 teorías** con estos criterios.

B2. Clasificaciones de modelos y teorías (muy preguntado)

Paradigmas de Kérouac

	CATEGORIZACIÓN	INTEGRACIÓN	TRANSFORMACIÓN
Época	1850-1950 (raíces ss. XVIII-XIX)	1950-1975	1975 en adelante
Visión	Fragmentada, causa única. Persona = suma de partes	Multicausal; persona biopsicosocial e integrada	Fenómeno único, contextual e irrepetible; visión holística
Orientación	Salud pública (Nightingale) y enfermedad	Hacia la persona	Apertura al mundo
Cuidado	"**Hacer para**"; paciente pasivo	"**Actuar con**"	"**Estar con**"
Enfermera	Realizadora de tareas	**Consejera**	**Compañera**
Salud	Ausencia de enfermedad	Ideal, capacidad de adaptación	Valor y proceso
Teóricas	**Nightingale**	**Henderson, Orem, Peplau, Roy**, Neuman, Johnson	**Rogers, Watson, Leininger**, Parse, Newman

Escuelas de pensamiento (Meleis y Kérouac)

Escuela	Pregunta	Teóricas
Necesidades (influida por Maslow)	¿**Qué** hacen las enfermeras?	**Henderson, Orem, Abdellah**
Interacción	¿**Cómo** hacen lo que hacen?	**Peplau, Orlando, King** (Travelbee)
Efectos deseables	¿**Por qué** hacen lo que hacen?	**Johnson, Roy, Neuman, Levine**
Promoción de la salud	¿**A quién** van dirigidos los cuidados?	**Moyra Allen, Nola Pender**
Ser humano unitario	¿A quién? (visión holística y energética)	**Rogers, Margaret Newman, Rizzo Parse**
Caring	¿Cómo? (dimensión existencial y transpersonal)	**Leininger, Watson, Benner**

Truco: Qué = Necesidades; Cómo = Interacción o Caring; Por qué = Efectos deseables; A quién = Promoción de la salud o Ser unitario.

Tendencias

Autor (criterio)	Tendencia	Teóricas
Paul Beck (relación con la salud)	**Ecologista** (salud-naturaleza)	Nightingale
	Existencialista (salud-psicología)	Peplau, Roy, King, Levine
	Cósmica (salud-medio ambiente/energía)	Rogers, Neuman, Johnson
	Sociológica (salud-dinámica social)	Orem
UNED (rol de la enfermera)	**Naturalista**	Nightingale
	Suplencia y ayuda	Henderson, Orem
	Interrelación	Peplau, Roy, Rogers, King, Levine
Marriner (significado de la enfermería)	**Humanistas** (arte y ciencia)	Nightingale, Henderson, Orem, Leininger, Watson
	Relaciones interpersonales	Peplau, Travelbee
	Sistemas	Johnson, Neuman
	Campos energéticos	Rogers

Nivel de abstracción: Marriner y Raile Alligood

Filosofías	Modelos conceptuales	Teorías	Teorías de nivel medio
Nightingale, Watson, Benner (Ray, Martinsen, Eriksson)	Orem, Rogers, Roy, King, Levine, Neuman, Johnson	Peplau, Leininger (Meleis, Newman, Parse)	Mercer, Mishel, Kolcaba, Pender, Beck. Son las más útiles en la clínica

Colley (según su función, de menor a mayor desarrollo): **descriptiva**, **explicativa**, **predictiva** y **prescriptiva**. **Benavent** (4 orientaciones históricas): **entorno** (Nightingale), **enfermedad**, **persona** e **interacción persona-entorno**.

B3. Las teóricas que más caen

Florence Nightingale: Teoría del Entorno (1859)

- El **entorno** es su concepto central. La **enfermedad es un proceso reparador** de la naturaleza.
- La enfermera **sitúa al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe** sobre él.
- Salud: ausencia de enfermedad y capacidad de usar todos los recursos propios. Persona: **pasiva**.
- Componentes del entorno, con la regla "**V**as **Y** **T**e **R**íes **D**e **H**enderson": **V**entilación, **I**luminación, **T**emperatura, **R**uido, **D**ieta e **H**igiene.
- Distingue la enfermería de la **salud** (prevención) y la enfermería del **enfermo**.
- **Clasificación**: paradigma de **Categorización** (salud pública). **No pertenece a ninguna escuela**, por ser pionera. Tendencia **ecologista, naturalista y humanista**.

Virginia Henderson: las 14 necesidades (1955)

- **Definición aceptada por el CIE**: "La única función de la enfermera es **asistir al individuo, sano o enfermo**, en la realización de aquellas actividades que contribuyen a su salud o recuperación (o a una **muerte serena**), que realizaría sin ayuda si tuviera la **fuerza, la voluntad o el conocimiento** necesarios."
- **Salud** = **independencia** en la satisfacción de las necesidades. El objetivo es la independencia lo antes posible.
- **Fuentes de dificultad**: falta de **fuerza**, de **conocimiento** o de **voluntad**.
- **Roles de la enfermera**: **sustituta** (hace por él), **ayudante** (colabora) y **compañera** (fomenta la independencia).
- "Necesidad" no significa carencia, sino requisito vital.

1. Respirar normalmente	8. Higiene e integridad de la piel
2. Comer y beber adecuadamente	9. Evitar peligros del entorno (y no lesionar a otros)
3. Eliminar por todas las vías	10. Comunicarse con los demás
4. Moverse y mantener la postura	11. Vivir según sus creencias y valores
5. Dormir y descansar	12. Trabajar / realizarse
6. Vestirse y desvestirse	13. Actividades recreativas
7. Mantener la temperatura corporal	14. Aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad

- **Clasificación**: paradigma de **Integración** (según Kérouac). Escuela de **Necesidades**. Tendencia de **suplencia-ayuda** y humanista.

Dorothea Orem: Teoría General del Autocuidado (década de 1960)

- Son **3 teorías** enlazadas:
  - **Teoría del autocuidado**. Los **requisitos de autocuidado (RAC)** pueden ser **universales**, del **desarrollo** o de **desviación de la salud**.
  - **Teoría del déficit de autocuidado** (el **núcleo**): hay déficit cuando la **agencia de autocuidado** (capacidad) es menor que la **demanda de autocuidado terapéutico**. Ahí empieza la enfermería.
  - **Teoría de los sistemas de enfermería**: **totalmente compensador** (paciente inconsciente), **parcialmente compensador** (se comparte) y **de apoyo-educación** (el paciente puede; la enfermera enseña y guía).
- **5 métodos de ayuda**: actuar por el paciente, guiarle, enseñarle, apoyarle y procurar un entorno favorable.
- Otros conceptos: **cuidado dependiente** (el que se da a otro dependiente) y **factores condicionantes básicos** (edad, sexo, estado de salud...).
- Salud: estado de **totalidad estructural y funcional**.
- **Clasificación**: paradigma de **Integración**. Escuela de **Necesidades**. Tendencia **sociológica**, de suplencia y humanista.

Hildegard Peplau: Relaciones Interpersonales (1952)

- "**Madre de la enfermería psiquiátrica**". Es el **primer modelo centrado en la relación enfermera-paciente**. Enfermería **psicodinámica**: un proceso interpersonal terapéutico y educativo.
- **4 fases** (mnemotecnia **O-I-E-R**): **Orientación** (se define el problema), **Identificación** (confianza), **Explotación o aprovechamiento** (usa los recursos) y **Resolución** (se cierra el vínculo).
- **6 roles**: **extraño**, **persona recurso**, **docente**, **líder**, **sustituto** y **consejero** (el **más importante**).
- Salud: desarrollo de la personalidad hacia la madurez.
- **Clasificación**: paradigma de **Integración**. Escuela de **Interacción**. Tendencia **existencialista**, de interrelación e interpersonal.

Callista Roy: Modelo de Adaptación (1976)

- La persona es un **sistema adaptativo** abierto. Salud: **proceso de ser y llegar a ser una persona integrada**.
- **Estímulos**: **focal** (el inmediato), **contextuales** (el resto de los presentes) y **residuales** (efecto incierto: creencias, pasado).
- **Mecanismos de afrontamiento**: subsistema **regulador** (fisiológico) y subsistema **cognitivo** (psicosocial).
- **4 modos adaptativos**: **fisiológico**, **autoimagen o autoconcepto**, **dominio del rol** e **interdependencia**.
- La enfermera **gestiona los estímulos** para que la respuesta sea adaptativa.
- **Clasificación**: paradigma de **Integración**. Escuela de **Efectos deseables**. Tendencia **existencialista** y de interrelación.

Martha Rogers: Seres Humanos Unitarios (1970)

- La persona es un **campo de energía** irreductible, indivisible y **pandimensional**, en interacción continua con el campo del entorno.
- **4 conceptos**: **campos de energía**, **universo de sistemas abiertos**, **patrones** y **pandimensionalidad**.
- **Principios de homeodinámica**: **Resonancia** (cambios en los patrones de onda), **Helicidad** (cambio continuo, innovador e impredecible, en espiral) e **Integralidad** (interacción mutua persona-entorno).
- Intervenciones **no invasivas**: **tacto terapéutico**, música, luz, color, meditación.
- **Clasificación**: paradigma de **Transformación**. Escuela del **Ser humano unitario**. Tendencia **cósmica** y de **campos energéticos**.

Madeleine Leininger: Cuidados Culturales (Enfermería Transcultural)

- **Primera enfermera doctorada en antropología** y **fundadora de la enfermería transcultural**.
- El cuidado es **universal**, pero sus expresiones son **diversas**. Objetivo: **cuidados culturalmente congruentes**. Distingue cuidados **genéricos o populares** y **profesionales**.
- **3 modos de acción**: **conservación o mantenimiento** (prácticas beneficiosas), **adaptación o negociación** y **reestructuración o reorientación** (cambiar las prácticas nocivas).
- **Clasificación**: paradigma de **Transformación**. Escuela del **Caring**. Tendencia **humanista**.

Jean Watson: Cuidado Humano / Transpersonal (1979)

- El **cuidado (caring)** es la esencia de la enfermería. Distingue **cuidado** (tarea de enfermería) y **curación** (tarea de la medicina).
- Persona: **cuerpo, mente y alma**. Salud: **armonía entre mente, cuerpo y espíritu**.
- **10 factores de cuidado (carative factors)**, que evolucionaron a los **procesos caritas**. Ejemplos: sistema de valores **humanístico-altruista**, **fe-esperanza**, relación de ayuda-confianza, expresión de sentimientos y uso del método científico.
- Conceptos: **momento de cuidado** y **relación transpersonal**. Se basa en Maslow y en Carl Rogers.
- **Clasificación**: paradigma de **Transformación**. Escuela del **Caring**. Tendencia **humanista**.

Otras teóricas: lo esencial de cada una

Teórica	Modelo	Lo que preguntan
Myra Levine (1967)	Conservación	**4 principios de conservación**: energía, integridad **estructural**, integridad **personal** e integridad **social**. Escuela de Efectos deseables
Dorothy Johnson	Sistema conductual	**7 subsistemas**: afiliativo, dependencia, ingestión, eliminación, sexual, realización y agresivo-protector. Efectos deseables
Betty Neuman	Sistemas	**Estresores** (intra-, inter- y extrapersonales); **líneas de defensa** (flexible y normal) y **de resistencia**; **prevención en 3 niveles**. Efectos deseables
Ida Jean Orlando	Proceso deliberativo	**Necesidad inmediata**; **validar** con el paciente y no inferir; acción **deliberada, no automática**. Interacción
Imogene King	Consecución de objetivos	Logro de **metas** mediante la interacción y las **transacciones**. Interacción
Joyce Travelbee	Relación persona a persona	Encontrar **sentido al sufrimiento**
Faye G. Abdellah	Tipología de problemas	**21 problemas de enfermería** (evolución de Henderson). Necesidades
Patricia Benner (1984)	De principiante a experta	Basada en **Dreyfus**. **5 niveles**: principiante, principiante avanzada, **competente (2-3 años)**, eficiente y experta. *Know-how* frente a *know-that*. Caring
Nola Pender (1982)	Promoción de la salud	Basada en **Bandura**: beneficios y barreras percibidas, **autoeficacia**, influencias interpersonales. Promoción de la salud
Roper-Logan-Tierney	Modelo de vida	**12 actividades de la vida diaria**
Marjory Gordon	Patrones funcionales	**11 patrones funcionales** para la valoración
Kristen Swanson	Caring	**5 procesos**: conocer, estar con, hacer por, posibilitar y mantener las creencias
Merle Mishel	Incertidumbre	La incertidumbre ante la enfermedad influye en el afrontamiento
Katharine Kolcaba	Confort	**Alivio, tranquilidad y trascendencia**
Lydia Hall	Esencia, cuidado y curación	**3 círculos**: cuidado (enfermera), núcleo (persona) y curación (equipo)

TRAMPAS DE EXAMEN

! Números que se cruzan: Henderson = **14** necesidades; Abdellah = **21** problemas; Gordon = **11** patrones; Roper = **12** AVD; Johnson = **7** subsistemas; Watson = **10** factores; Benner = **5** niveles; Peplau = **4** fases y **6** roles.

! Henderson está en Integración (Kérouac), aunque su enfoque por necesidades "descompone" el cuidado. Si te preguntan el paradigma, marca **Integración**.

! Nightingale no pertenece a ninguna escuela (es la pionera).

! En Orem, el núcleo es la teoría del **déficit** de autocuidado. Sin déficit no hay intervención enfermera.

! Para Peplau, el rol más importante es el de **consejero**.

! Roy, estímulo **focal** = el inmediato. Rogers, **helicidad** = cambio en espiral e impredecible.

BLOQUE C · Constitución Española, organización territorial y Estatuto de Murcia

1. La Constitución de 1978: datos básicos

Hito	Fecha
Aprobada por las Cortes	31 octubre 1978
Referéndum (trampa: no es la entrada en vigor)	**6 diciembre 1978**
Sanción y promulgación por el Rey	27 diciembre 1978
Entrada en vigor (BOE)	**29 diciembre 1978**

- **169 artículos**: Título Preliminar + 10 Títulos (11 en total; el Preliminar no lleva número).
- Disposiciones **4-9-1-1**: 4 Adicionales, 9 Transitorias, 1 Derogatoria, 1 Final.
- **Solo 3 reformas** (Constitución rígida):
  - **1992**: art. 13.2, sufragio pasivo de extranjeros en municipales (Maastricht).
  - **2011**: art. 135, estabilidad presupuestaria.
  - **2024**: art. 49, "disminuidos" pasa a "**personas con discapacidad**".

Estructura por Títulos

Título	Contenido	Arts.
Preliminar	Principios básicos	1-9
I	Derechos y deberes fundamentales	10-55
II	La Corona	56-65
III	Cortes Generales	66-96
IV	Gobierno y Administración	97-107
V	Relaciones Gobierno-Cortes	108-116
VI	Poder Judicial	117-127
VII	Economía y Hacienda	128-136
VIII	Organización territorial	137-158
IX	Tribunal Constitucional	159-165
X	Reforma constitucional	166-169

Reforma constitucional (Título X)

- **Ordinaria (art. 167)**: reformas parciales.
  - Requiere **3/5** de cada Cámara. Si no hay acuerdo, comisión paritaria.
  - Si el Senado aprueba por mayoría absoluta sin llegar a 3/5, el Congreso puede aprobarla con **2/3**.
  - Referéndum solo si lo pide **1/10** de los miembros de cualquier Cámara en **15 días**.
- **Agravada (art. 168)**: revisión total, Título Preliminar, arts. 15-29 (Sección 1ª) o Título II (Corona).
  - **2/3** de cada Cámara, **disolución inmediata de las Cortes**, ratificación por **2/3** de las nuevas Cámaras y **referéndum obligatorio**.

2. Título Preliminar (arts. 1-9)

- **Art. 1**: España es un Estado **social y democrático de Derecho**.
  - **Valores superiores**: **libertad, justicia, igualdad y pluralismo político**.
  - La **soberanía nacional reside en el pueblo español**.
  - Forma política: **Monarquía parlamentaria**.
- **Art. 2**: indisoluble unidad de la Nación + derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones + solidaridad.
- **Art. 3**: castellano oficial. Se tiene el **DEBER de conocerlo** y el **DERECHO a usarlo**.
- **Art. 4**: bandera roja-amarilla-roja; la amarilla es de **doble anchura que cada una de las rojas**.

- **Art. 5**: capital, la villa de **Madrid**.
- **Arts. 6 y 7**: partidos políticos (6), sindicatos y asociaciones empresariales (7); estructura y funcionamiento **democráticos**.
- **Art. 8**: Fuerzas Armadas = Ejército de **Tierra**, la **Armada** y el Ejército del **Aire y del Espacio**.
- **Art. 9.2**: los poderes públicos promueven que la libertad y la igualdad sean **reales y efectivas**.
- **Art. 9.3**, principios garantizados:
  - Legalidad, jerarquía normativa y publicidad de las normas.
  - Irretroactividad de las disposiciones **sancionadoras no favorables o restrictivas** de derechos individuales.
  - Seguridad jurídica, responsabilidad e **interdicción de la arbitrariedad** de los poderes públicos.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Los valores superiores son SOLO esos 4. "Solidaridad", "paz", "legalidad" o "democracia": FALSO.

! Art. 3: no inviertas los términos ("derecho a conocerlo y deber de usarlo" es FALSO).

! Art. 8: "Marina" o "Ejército de Mar" es FALSO; es la **Armada**.

! Art. 9.3: la CE NO garantiza la irretroactividad de "todas" las disposiciones. Una norma sancionadora más favorable SÍ puede ser retroactiva.

3. Título I: Derechos y deberes fundamentales (arts. 10-55)

- **Art. 10**: la **dignidad de la persona** es fundamento del orden político y de la paz social.
- **Art. 10.2**: los derechos se interpretan conforme a la **Declaración Universal de Derechos Humanos** y los tratados ratificados por España.

Capítulo I: españoles y extranjeros (arts. 11-13)

- **Art. 12**: mayoría de edad a los **18 años**.
- **Art. 13**: la extradición se concede por tratado o ley (reciprocidad). Se excluyen los **delitos políticos**, pero el **terrorismo NO** se considera delito político.

Capítulo II: derechos y libertades (arts. 14-38)

Art. 14: igualdad ante la ley y prohibición de discriminación (raza, sexo, religión, opinión...).

Sección 1ª (arts. 15-29): Derechos fundamentales	**Sección 2ª (arts. 30-38): Derechos y deberes de los ciudadanos**
MÁXIMA protección: **Ley Orgánica** + **recurso de amparo**	Protección media: **ley ordinaria**, **SIN amparo**
15 Vida e integridad física y moral. Prohíbe la tortura. Pena de muerte abolida "salvo leyes penales militares en tiempo de guerra" (base de las leyes de aborto y eutanasia)	**30** Defensa de España. **30.2 Objeción de conciencia: SÍ tiene amparo** (excepción)
16 Libertad ideológica, religiosa y de culto; ninguna confesión es estatal (Testigos de Jehová)	**32** Matrimonio
17 Libertad. Detención preventiva máx. **72 h**. *Habeas corpus*	**33** Propiedad privada y herencia
18 Honor, intimidad y propia imagen; inviolabilidad del domicilio; secreto de comunicaciones (historia clínica, protección de datos)	**36** Colegios Profesionales, con estructura democrática
20 Libertad de expresión y cátedra; secreto profesional	
24 Tutela judicial efectiva	
27 Educación (básica obligatoria y gratuita)	

Capítulo III: principios rectores (arts. 39-52)

No son exigibles directamente ante un juez: son mandatos para que los poderes públicos legislen. **No tienen amparo.**

- **Art. 39**: familia e infancia.
- **Art. 41**: régimen público de Seguridad Social.
- **Art. 43**: protección de la salud.
- **Art. 47**: vivienda digna.
- **Art. 49**: personas con discapacidad (reforma de 2024).
- **Art. 50**: tercera edad (pensiones).

Capítulo IV: garantías (arts. 53-54)

- **Art. 53**: el **recurso de amparo** ante el Tribunal Constitucional SOLO protege el **art. 14**, los **arts. 15-29** y el **art. 30.2**.
- **Art. 54**: **Defensor del Pueblo**, alto comisionado elegido por las **Cortes Generales**; defiende los derechos del Título I y supervisa a la Administración.

Capítulo V: suspensión de derechos (art. 55)

- **Suspensión general**: solo en estados de **excepción y sitio**. El estado de **alarma NO suspende** derechos fundamentales.
- **Suspensión individual**: investigaciones de terrorismo o bandas armadas (ampliar las 72 h, intervenir comunicaciones), con control parlamentario posterior.

TRAMPAS DE EXAMEN

! "Un paciente en lista de espera recurre en amparo por el art. 43": NO se admite. La salud es un principio rector, sin amparo.

! El Defensor del Pueblo lo eligen las **Cortes Generales**, no el Rey ni el Gobierno.

! El art. 30.2 está en la Sección 2ª pero SÍ tiene amparo (protege al sanitario objetor en aborto o eutanasia).

! Art. 49 actual: "personas con discapacidad". Si aparece "disminuidos" como redacción vigente: FALSO.

4. Artículo 43: protección de la salud (pregunta fija)

- **43.1**: se reconoce el **derecho a la protección de la salud**.
- **43.2**: compete a los poderes públicos **organizar y tutelar la salud pública** mediante medidas preventivas y prestaciones; la ley fija derechos y deberes.
- **43.3**: los poderes públicos fomentan la **educación sanitaria, la educación física y el deporte**, y facilitan la **adecuada utilización del ocio**.
- Naturaleza: **principio rector** (Cap. III) y **derecho de configuración legal**: necesita leyes y presupuesto. Sin eficacia directa ni amparo.

Leyes que lo desarrollan

Ley	Clave
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad	Crea el **SNS**: universal y financiado por impuestos. Supera la beneficencia y el aseguramiento laboral. **Art. 3.1**: prioridad a la **promoción de la salud y la prevención**
Ley 16/2003	Cohesión y Calidad del SNS (evitar desigualdades entre CCAA)
Ley 33/2011	General de Salud Pública

5. Las Cortes Generales (Título III, arts. 66-96)

- Bicameralismo **asimétrico**: el Congreso pesa más que el Senado. Las Cortes son **inviolables**.
- Funciones: **potestad legislativa**, aprobar los **Presupuestos Generales del Estado** y **controlar al Gobierno**.
- **Congreso**: entre 300 y 400 diputados (la ley electoral los fija en **350**). Circunscripción: la **provincia** (+ Ceuta y Melilla). Mandato de 4 años.
- **Senado**: cámara de **representación territorial**. **4 senadores por provincia peninsular** + senadores designados por los parlamentos autonómicos. Mandato de 4 años.

Iniciativa legislativa

- **Proyecto de ley**: lo presenta el **Gobierno**. Tiene prioridad y no necesita toma en consideración.
- **Proposición de ley**: la presentan el Congreso, el Senado, las Asambleas de las CCAA o la **iniciativa popular (500.000 firmas)**. Necesita toma en consideración.
- El Senado tiene **2 meses** para vetar o enmendar (**20 días** si es urgente). La última palabra la tiene el Congreso.
- El **Rey sanciona en 15 días**; es un acto debido y **no puede negarse**.

Ley Orgánica (art. 81)	Ley Ordinaria
Derechos fundamentales y libertades públicas (15-29), **Estatutos de Autonomía** y **régimen electoral**	Todo lo demás
Mayoría absoluta del Congreso (176) en votación final sobre el conjunto del proyecto	**Mayoría simple**

Normas del Gobierno con rango de ley (muy preguntado)

	DECRETO-LEY (art. 86)	DECRETO LEGISLATIVO (arts. 82-85)
Motivo	**Extraordinaria y urgente necesidad**	**Delegación previa** de las Cortes
Control	**Posterior**: el Congreso lo convalida o deroga en **30 días**	**Previo**: Ley de Bases (textos articulados) o Ley ordinaria (textos refundidos)
Límites	No puede afectar a instituciones básicas, derechos del Título I, régimen de las CCAA ni ley electoral	Materia concreta y plazo fijado. **Prohibido subdelegar**

Truco: en el decreto-ley el Gobierno "dispara primero" y el Parlamento revisa después. En el decreto legislativo el Parlamento autoriza primero y el Gobierno redacta después.

Plazos clave

Plazo	Qué es
72 horas	Detención preventiva (art. 17)
15 días	Sanción de las leyes por el Rey (art. 91)
20 días	Senado en proyectos urgentes
30 días	Convalidación de un decreto-ley por el Congreso
2 meses	Plazo ordinario del Senado / bloqueo de investidura (disolución y nuevas elecciones)

6. El Gobierno y la Administración (Título IV, arts. 97-107)

- **Art. 97**: el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
- Composición: Presidente, Vicepresidentes (si los hay), Ministros y demás miembros que fije la ley.
- **Ministros**: los nombra y separa **el Rey, a propuesta del Presidente**.

Investidura (art. 99)

- El Rey consulta a los grupos políticos y propone un candidato, que expone su programa ante el Congreso.
- **1ª votación**: mayoría **absoluta**. **2ª votación (48 h después)**: mayoría **simple**.
- Si pasan **2 meses** desde la 1ª votación sin investidura, el Rey **disuelve las Cortes** y convoca elecciones.
- El candidato **NO necesita ser diputado**.

Cese y responsabilidad política

- Causas de cese: elecciones generales, dimisión o fallecimiento del Presidente, o pérdida de la confianza parlamentaria. Después sigue **en funciones**.
- **Cuestión de confianza**: la plantea el Presidente; se gana con mayoría **simple**.
- **Moción de censura**: la propone al menos **1/10 de los diputados (35)**, es **constructiva** (con candidato alternativo) y necesita mayoría **absoluta (176)**.

La Administración Pública

- **Art. 103**: sirve con objetividad los intereses generales según los principios de **Eficacia, Jerarquía, Descentralización, Desconcentración y Coordinación**.
- **Ley 55/2003, Estatuto Marco** del personal estatutario de los servicios de salud: legislación básica estatal (**art. 149.1.18**). Establece una relación funcionarial especial y garantiza la movilidad en todo el SNS.

TRAMPAS DE EXAMEN

! "Los ministros los nombra el Presidente": FALSO. Los nombra el Rey a propuesta del Presidente.

! Moción de censura con "mayoría simple": FALSO. Requiere mayoría absoluta.

! Art. 103: "Eficiencia" o "Centralización" son FALSAS. Es **Eficacia**.

7. Organización territorial del Estado (Título VIII, arts. 137-158)

- El Estado se organiza en **municipios, provincias y Comunidades Autónomas**, todos con autonomía para gestionar sus intereses.
- **Art. 138, solidaridad**: equilibrio económico entre territorios; los Estatutos no pueden crear privilegios económicos o sociales.
- **Art. 139, igualdad**: mismos derechos y obligaciones en todo el territorio; libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales.

CCAA: art. 148.1.21	ESTADO (exclusiva): art. 149.1.16
Sanidad e higiene: gestión de hospitales, centros de salud y asistencia diaria (Servicios de Salud como el SMS)	1. **Sanidad exterior** (puertos, aeropuertos, fronteras) 2. **Bases y coordinación general de la sanidad** 3. **Legislación sobre productos farmacéuticos** (autorización, precio y financiación de medicamentos)

- **Art. 149.3, cláusula de supletoriedad**: lo no asumido en los Estatutos corresponde al Estado; el Derecho estatal es supletorio del autonómico.

8. Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia

- Aprobado el **9 de junio de 1982** (coincide con el **Día de la Región**).
- Acceso a la autonomía por el **art. 143 CE** ("vía lenta"). Trampa: el art. 151 es el de Andalucía, Galicia, País Vasco y Cataluña.
- **Territorio (art. 2)**: los municipios de la provincia de Murcia.
- **Bandera (art. 4)**: fondo **rojo carmesí**.
  - Ángulo superior izquierdo: **4 castillos** de oro, de dos en dos.
  - Ángulo inferior derecho: **7 coronas** reales en 4 filas, en orden **1-3-2-1**.

Ciudad	Sede
Murcia	Capital de la Región, sede de la **Presidencia** y del **Consejo de Gobierno**
Cartagena	Sede de la **Asamblea Regional** (poder legislativo)

Reforma del Estatuto (Título VI)

- **Iniciativa**: **1/4** de la Asamblea Regional; **1/3** de los municipios que representen la mayoría del censo; el **Consejo de Gobierno**; o el **Gobierno de la Nación / Cortes Generales**.
- Aprobación en la Asamblea: **3/5** de sus miembros.
- Si la reforma solo sirve para **asumir nuevas competencias**, basta con **mayoría absoluta**.
- Después se aprueba en las Cortes Generales como **Ley Orgánica**.

9. La Asamblea Regional

- Ejerce la potestad legislativa; es **inviolable** (art. 21).
- **Funciones (art. 22)**: legislar, aprobar los **Presupuestos regionales** (incluido el del SMS) y controlar al Ejecutivo.
- Sistema electoral tras la reforma de 2015 (memorizar la tríada):
  - **45 diputados**, con mandato de 4 años.
  - **Circunscripción única** (antes había 5).
  - **Barrera electoral del 3 %** (antes era del 5 %).
- Sede: **Cartagena**. Puede reunirse en otro lugar por acuerdo de la Mesa y la Junta de Portavoces.

Órgano	Composición y función
Mesa	Presidente + 2 vicepresidentes + 2 secretarios. Dirige y administra la cámara. Vota por persona
Junta de Portavoces	Presidente + 1 portavoz por grupo. Fija el orden del día. **Voto ponderado**
Pleno	Los 45 diputados; órgano supremo
Comisiones	Trabajo especializado previo al Pleno (p. ej., Comisión de Sanidad)
Diputación Permanente	Actúa en vacaciones parlamentarias o tras la disolución

10. Presidente de la Comunidad Autónoma (Ley 6/2004)

- Tiene la **suprema representación** de la Región y la **representación ordinaria del Estado** en ella, y preside el Consejo de Gobierno.
- El candidato lo propone el Presidente de la Asamblea tras consultar a los grupos, y **debe ser obligatoriamente Diputado Regional**.
- **1ª votación**: mayoría **absoluta (23)**. **2ª votación (48 h después)**: mayoría **simple**.
- Si pasan **2 meses** sin elegir Presidente, la Asamblea se disuelve y se convocan elecciones.
- **Cuestión de confianza**: mayoría **simple**.
- **Moción de censura**: la propone **1/10 de la Asamblea (5 diputados)**, es constructiva y requiere mayoría **absoluta (23)**.

TRAMPAS DE EXAMEN

! "Para ser Presidente del Gobierno de la Nación hay que ser diputado": FALSO. "Para ser Presidente de Murcia hay que ser Diputado Regional": VERDADERO.

! "Capital de la Región" = Murcia. "Sede de la Asamblea / poder legislativo" = Cartagena.

! El voto ponderado se usa en la **Junta de Portavoces**, no en la Mesa.

! Reforma electoral: 45 diputados, circunscripción única y barrera del 3 %. El 5 % y las 5 circunscripciones son trampa.

11. Consejo de Gobierno y Administración Regional

- **Consejo de Gobierno**: Presidente + Vicepresidentes + **Consejeros**. Tiene la función ejecutiva y la **potestad reglamentaria**.
- Los **Consejeros** los nombra y separa **libremente el Presidente**, sin votación en la Asamblea.
- **Ley 7/2004** (Organización y Régimen Jurídico de la Administración regional):
  - **Órganos superiores**: Presidente, Vicepresidente y Consejeros.
  - **Órganos directivos**: Secretarios Generales y Directores Generales.
- **Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia**: crea el **Servicio Murciano de Salud (SMS)**.
  - Es un **Ente Público** (entidad de Derecho Público) con **personalidad jurídica propia**, patrimonio propio y plena capacidad de obrar.
  - Está adscrito a la **Consejería de Salud** y gestiona Atención Primaria, hospitales, Salud Mental y Urgencias.

12. Instituciones consultivas y de control de Murcia

- **Consejo Jurídico**: máximo órgano consultivo en materia legal; emite dictámenes. Sede en Murcia; en protocolo va justo detrás del Consejo de Gobierno.
- **Consejo Económico y Social (CES)**: órgano consultivo en materia socioeconómica y laboral; emite informes preceptivos sobre anteproyectos.
- **Comisionado de la Transparencia** (según el manual): órgano **unipersonal**, sustituye al antiguo Consejo de la Transparencia (colegiado). Lo ratifica la Asamblea para **4 años**.

TRAMPAS DE EXAMEN

! "El SMS es una Dirección General de la Consejería de Salud": FALSO. Es un **Ente Público** con personalidad jurídica propia.

! Director General y Secretario General son órganos **directivos**, NO superiores.

! Leyes regionales clave: **4/1994** (Salud y SMS) y **7/2004** (Administración regional).